

TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN THƯƠNG BINH, BỆNH BINH CHO HOẠT ĐỘNG CHIẾN ĐẤU PHỐI HỢP CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG ĐỊA PHƯƠNG VỚI SƯ ĐOÀN BỘ BINH TIẾN CÔNG ĐỊCH CƠ ĐỘNG

Thượng tá, ThS NGUYỄN HỒNG QUÂN

Khoa Chiến thuật, Chiến dịch/Học viện Chính trị

Hoạt động chiến đấu phối hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương với sư đoàn bộ binh tiến công địch cơ động là sự kết hợp sức mạnh của LLVT tại chỗ với sức mạnh của bộ đội chủ lực nhằm sát thương, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực, phương tiện địch, làm thất bại ý định cơ động của chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tác chiến tiếp theo của cấp trên và LLVT địa phương phát triển. Để đảm bảo cho LLVT địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, cần giải quyết nhiều vấn đề về nghệ thuật tác chiến cũng như các mặt bảo đảm; trong đó, tổ chức vận chuyển thương binh, bệnh binh (TB, BB) là nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của quá trình chiến đấu phối hợp.

Vận chuyển TB, BB, bao gồm tổng hợp các biện pháp để đưa TB, BB ra khỏi khu vực chiến đấu về các tuyến quân y kịp thời, an toàn theo chỉ định, bảo đảm sức cơ động cho bộ đội và các phân đội quân y. Công tác chuyển thương có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cứu chữa. Lực lượng tham gia vận chuyển TB, BB cho LLVT địa phương chiến đấu phối hợp với sư đoàn tiến công địch cơ động, gồm: Lực lượng vận tải quân sự địa phương, dân quân tự vệ, bộ đội, lực lượng vận tải huy động tại địa phương, lực lượng vận tải quân khu tăng cường (nếu có). Ngoài ra, còn có các ban, ngành kinh tế - xã hội, các đoàn thể địa phương và nhân dân tham gia vận chuyển. Trong chiến đấu phối hợp với sư đoàn, tùy vào điều kiện địa lý và

khả năng kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng kết hợp các phương tiện vận tải hiện có của khu vực phòng thủ, như: Xe ô tô, mô-tô, xe thô sơ, tàu, thuyền, bè, mảng, cồng bộ...

Lực lượng tham gia chiến đấu phối hợp với sư đoàn bộ binh tiến công địch cơ động là trung đoàn bộ binh và một số phân đội binh chủng chiến đấu, bảo đảm; số lượng TB, BB của LLVT khoảng 464 người; trong đó, của bộ đội địa phương là 407 người; của dân quân tự vệ là 57 người. Số lượng TB, BB ngày cao nhất là 165 người; trong đó, bộ đội địa phương là 144 người, dân quân tự vệ là 21 người. Cân đối giữa nhu cầu vận chuyển TB, BB và khả năng vận chuyển của lực lượng vận tải cho thấy: Lực lượng vận tải trong biên chế thời chiến của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được tổ chức thành 1 đại đội vận tải hỗn hợp, gồm 1 trung đội vận tải ô tô, 3 trung đội vận tải bộ. Lực lượng vận tải huy động của địa phương: Từ 1 trung đội đến 1 đại đội vận tải ô tô; 2 đại đội đến 1 tiểu đoàn vận tải bộ. Với thành phần lực lượng vận tải trên, khả năng vận chuyển của vận tải bộ là 1.012 tấn/chuyến; vận tải cơ giới vận chuyển 150.200 tấn/chuyến, cơ động lực lượng 900 đến 1.000 người/chuyến. Lực lượng vận tải có thể vận chuyển mỗi ngày 1 đến 2 chuyến. Về nguyên tắc, hậu cần, kỹ thuật quân sự tỉnh phải tổ chức lực lượng, phương tiện đến quân y trung đoàn, các đơn vị trực thuộc tỉnh và các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực chuyển TB, BB về trạm quân y ở căn cứ, phân căn cứ hậu cần, kỹ thuật tỉnh. Về

phương tiện chuyển thương, do đặc điểm căn cứ, phân căn cứ hậu cần, kỹ thuật tính bố trí cách trạm quân y trung đoàn và các đơn vị tham gia chiến đấu phối hợp xa nên TB, BB được vận chuyển về quân y quân sự địa phương tỉnh chủ yếu bằng vận tải cơ giới. Tuy nhiên, tại thời điểm diễn ra hoạt động chiến đấu phối hợp với sư đoàn, các hướng (khu vực) tác chiến khác của khu vực phòng thủ tỉnh cũng diễn ra hết sức ác liệt, thương vong nhiều, nhu cầu vận chuyển TB, BB rất lớn. Vì vậy, việc tổ chức vận chuyển TB, BB cho LLVT địa phương tham gia chiến đấu phối hợp với sư đoàn gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Giải quyết khó khăn trên, hậu cần, kỹ thuật quân sự tỉnh cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, phân cấp cứu chữa, vận chuyển TB, BB cho hậu cần - kỹ thuật Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và các cơ sở y tế trong khu vực chiến đấu.

Theo lập luận ở trên, với khả năng lực lượng quân y quân sự địa phương tỉnh và lực lượng y tế địa phương đã được huy động, bố trí trong các căn cứ, phân căn cứ hậu cần, kỹ thuật thì đủ khả năng cứu chữa, vận chuyển hết số TB, BB trên. Tuy nhiên, tại thời điểm diễn ra hoạt động chiến đấu phối hợp với sư đoàn, các hướng, các khu vực tác chiến khác vẫn ác liệt, thương vong nhiều, có thể vượt quá khả năng bảo đảm của lực lượng hậu cần, kỹ thuật trong căn cứ, phân căn cứ. Giải quyết vấn đề này, hậu cần, kỹ thuật quân sự địa phương cần phân cấp một phần cứu chữa, vận chuyển TB, BB của LLVT địa phương tham gia chiến đấu phối hợp với sư đoàn cho hậu cần, kỹ thuật Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và các cơ sở y tế tuyến dưới. Cụ thể:

Lực lượng chiến đấu tạo thế, nghi binh; lực lượng chiến đấu sau lưng địch chủ yếu sử dụng các tiểu đoàn bộ binh của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và dân quân tự vệ. Theo nguyên tắc, TB, BB của các đơn vị tiểu đoàn bộ binh của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, sau khi được cứu chữa ở trạm quân y của Ban

Chỉ huy phòng thủ khu vực, được chuyển về quân y quân sự địa phương tỉnh; TB, BB của dân quân tự vệ được chuyển về các cơ sở dân y, như: Trạm y tế xã, phường, trung tâm y tế, bệnh viện khu vực để cứu chữa theo phân cấp. Tuy nhiên, để giảm khó khăn trong cứu chữa TB, BB cho tuyến quân y quân sự địa phương tỉnh, cần phân cấp cứu chữa TB, BB của lực lượng chiến đấu tạo thế, nghi binh; lực lượng chiến đấu sau lưng địch cho các cơ sở y tế tuyến dưới; phân cấp vận chuyển cho hậu cần, kỹ thuật Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực. Như vậy, TB, BB của các tiểu đoàn bộ binh thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực làm nhiệm vụ chiến đấu tạo thế, nghi binh; chiến đấu sau lưng địch sau khi được cứu chữa bước đầu ở tuyến quân y Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực sẽ được chuyển về các bệnh viện khu vực để thực hiện cứu chữa cơ bản; các trường hợp cần cứu chữa chuyên khoa thì được chuyển về bệnh viện tỉnh hoặc bệnh viện dã chiến của quân khu.

Thực hiện giải pháp trên, hậu cần, kỹ thuật quân sự địa phương tỉnh cần nắm chắc nhiệm vụ của các đơn vị, diễn biến chiến đấu, tình hình thương vong trên các hướng, mũi. Tham mưu cho Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tăng cường cho đơn vị khi có tình huống. Chủ động chuẩn bị phương án kết hợp quân - dân y trong bảo đảm cứu chữa TB, BB cho tác chiến khu vực phòng thủ nói chung và hoạt động chiến đấu của LLVT địa phương phối hợp với sư đoàn bộ binh tiến công địch cơ động nói riêng. Đồng thời, nắm chắc khả năng bảo đảm quân y của các đơn vị trong từng giai đoạn, từng thời điểm để có biện pháp phân cấp cứu chữa, vận chuyển phù hợp.

Hai là, tổ chức vận chuyển vượt tuyến khi cần thiết.

Đặc điểm của tiến công địch cơ động là tình biến động cao, bộ đội phải cơ động liên tục, trạm quân y của các đơn vị tham gia chiến đấu phối hợp cũng phải cơ động theo đội hình

chiến đấu của đơn vị. Vì lý do đó, ở những thời điểm nhất định, việc triển khai cứu chữa, vận chuyển TB, BB ở các đơn vị tiến công địch cơ động có thể không kịp thời. Để khắc phục khó khăn trên, hậu cần, kỹ thuật quân sự địa phương tỉnh cần tổ chức vận chuyển TB, BB vượt tuyến (khi cần thiết) để nhanh chóng đưa thương binh ra khỏi trận địa. Tức là, lực lượng vận tải quân sự địa phương tỉnh kết hợp vận chuyển vượt cấp một số loại vật chất hậu cần, kỹ thuật chuyển thẳng đến trận địa và nhận TB, BB từ tuyến tiểu đoàn về quân y quân sự địa phương tỉnh.

Trong tình huống thương vong lớn ngoài dự kiến, hậu cần, kỹ thuật quân sự địa phương tỉnh tổ chức vận chuyển vượt tuyến (vượt qua hậu cần, kỹ thuật trung đoàn của tỉnh làm nhiệm vụ tiến công địch cơ động) cho tiểu đoàn bộ binh tiến công trên hướng chủ yếu. Cụ thể: sử dụng số ô tô đã bổ sung vật chất cho đơn vị tại khu vực triển khai ở lại nhận và chuyển TB, BB từ đơn vị về thẳng tuyến quân y quân sự địa phương tỉnh. Ngoài ra, trong các trường hợp cần thiết, hậu cần, kỹ thuật quân sự địa phương tỉnh có thể tổ chức đội tải thương, để vận chuyển TB, BB vượt tuyến. Có thể sử dụng lực lượng vận tải bộ, dân công (đi cùng xe chở vật chất) đến trạm quân y tiểu đoàn vận chuyển thẳng về các cơ sở y tế gần đó trong khu vực phòng thủ hoặc bàn giao cho lực lượng vận tải cơ giới của quân sự địa phương tỉnh tiếp chuyển về trạm quân y trong căn cứ hoặc phân căn cứ hậu cần, kỹ thuật tỉnh.

Muốn vậy, hậu cần, kỹ thuật quân sự địa phương tỉnh cần thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến chiến đấu, tình hình thương vong trên các hướng để chỉ huy, chỉ đạo lực lượng vận tải vận chuyển TB, BB cho các đơn vị. Kịp thời sử dụng lực lượng vận tải quân sự địa phương tỉnh kết hợp với lực lượng, phương tiện huy động tại địa phương thành lập các đội tải thương vượt tuyến để vận chuyển TB, BB. Chú ý khu tổ chức vận chuyển vượt tuyến

cho tiểu đoàn chiến đấu trên hướng chủ yếu; đồng thời, phải bảo đảm việc vận chuyển TB, BB của các hướng khác, không để TB, BB cần chuyển về tuyến sau bị ùn tắc.

Ba là, huy động các lực lượng, phương tiện vận tải của địa phương tham gia vận chuyển TB, BB.

Đối với lực lượng vận tải quân sự địa phương tỉnh, phương tiện sử dụng để vận chuyển TB, BB, từ trận đánh về quân y quân sự địa phương tỉnh, chủ yếu là sử dụng vận tải ô tô. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể sử dụng ô tô để vận chuyển TB, BB được (do địch đánh phá ngăn chặn, điều kiện giao thông thuận lợi). Hơn nữa, tại thời điểm diễn ra trận chiến đấu phối hợp với sư đoàn tiến công địch cơ động, hậu cần, kỹ thuật quân sự địa phương tỉnh vừa phải tập trung vận chuyển TB, BB cho LLVT địa phương tham gia chiến đấu phối hợp với sư đoàn, vừa phải vận chuyển số lượng lớn TB, BB từ các hướng (khu vực) tác chiến khác về quân y quân sự địa phương tỉnh; có thể vượt quá khả năng của vận tải quân sự địa phương tỉnh. Đó là chưa tính lực lượng vận tải còn phải thực hiện nhiệm vụ bốc, xếp vận chuyển đạn hỏa lực cho các đơn vị. Để khắc phục tình trạng này, hậu cần, kỹ thuật quân sự địa phương tỉnh cần tham mưu cho Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huy động lực lượng, phương tiện vận tải địa phương tham gia vận chuyển TB, BB cho LLVT địa phương chiến đấu phối hợp với sư đoàn.

Theo đó, phương tiện vận tải của địa phương đã được huy động và bố trí trong các căn cứ, phân căn cứ hậu cần, kỹ thuật của khu vực phòng thủ, hậu cần, kỹ thuật quân sự địa phương tỉnh cần tính toán, đề xuất với Hội đồng cung cấp huy động thêm các lực lượng, phương tiện vận tải từ các ngành kinh tế - xã hội địa phương để bảo đảm cho hoạt động chiến đấu phối hợp. Các lực lượng, phương tiện huy động tại địa phương bao gồm: Các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ, đường thủy, các phương tiện vận tải thô sơ; dân quân

tự vệ, có thể có sự tham gia của lực lượng các ban, ngành và nhân dân trên địa bàn diễn ra hoạt động chiến đấu phối hợp với sư đoàn. Căn cứ vào tình hình cụ thể, ngoài lực lượng vận tải của địa phương đã huy động và được bố trí trong các căn cứ, phân căn cứ hậu cần, kỹ thuật của tỉnh; trong từng thời điểm diễn ra trận đánh phối hợp với sư đoàn, hậu cần, kỹ thuật quân sự địa phương tỉnh có thể đề xuất với Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huy động các lực lượng, phương tiện vận tải của các ban, ngành, các cơ sở kinh tế - xã hội của địa phương để vận chuyển TB, BB từ các đơn vị tới quân y trung đoàn hoặc thẳng từ cụm pháo binh, phòng không... về quân y quân sự địa phương tỉnh, về các cơ sở y tế của địa phương. Tuy nhiên, việc sử dụng các lực lượng, phương tiện vận tải của khu vực phòng thủ tham gia vận chuyển phải phù hợp với phân cấp, chỉ định cứu chữa, điều trị TB, BB của trận chiến đấu phối hợp với sư đoàn bộ binh ở các tuyến quân y, dân y. Lực lượng, phương tiện vận tải của địa phương được huy động có thể đảm nhiệm vận chuyển TB, BB cho các lực lượng chiến đấu nghi binh, tạo thế; lực lượng chiến đấu sau lưng địch và thương binh của lực lượng binh chủng. Ngoài ra, khi TB, BB nhiều, hậu cần, kỹ thuật quân sự địa phương tỉnh cần huy động lực lượng, phương tiện vận tải của khu vực phòng thủ, tổ chức thành tổ tải thương để nhanh chóng lấy TB, BB từ các hướng về (trong trường hợp cần tổ chức vận chuyển vượt tuyến). Đồng thời, lực lượng này tham gia vận chuyển TB, BB từ các tuyến cứu chữa bước đầu (quân y trung đoàn, bệnh viện khu vực...) về tuyến cứu chữa cơ bản.

Thực hiện giải pháp trên, hậu cần, kỹ thuật quân sự địa phương tỉnh cần nắm chắc tình hình, khả năng lực lượng, phương tiện vận tải của địa phương. Phân cấp trách nhiệm; hiệp đồng chặt chẽ về lực lượng, số lượng phương tiện vận tải của địa phương cần huy động đối với từng cấp. Hiệp đồng

cụ thể với địa phương về vận chuyển, phạm vi, thời gian tiến hành kết hợp cứu chữa, điều trị TB, BB với các đơn vị có liên quan. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể cho lực lượng, phương tiện vận tải của địa phương được huy động tham gia vận chuyển TB, BB; quá trình sử dụng phải có lực lượng vận tải chuyên nghiệp làm nòng cốt; phải có sự chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ, cụ thể về công tác chuyển thương.

Lực lượng vũ trang địa phương hoạt động chiến đấu phối hợp với sư đoàn bộ binh tiến công địch cơ động vận dụng nhiều hình thức và phương pháp hoạt động tác chiến linh hoạt, trên địa bàn rộng, diễn biến phức tạp, khẩn trương. Để tổ chức vận chuyển TB, BB cho LLVT địa phương tham gia chiến đấu phối hợp với sư đoàn có hiệu quả, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng. Trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố tác động, hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ cần xác định nhu cầu vận chuyển, tính toán, cân đối khả năng vận chuyển để xác định các biện pháp tổ chức vận chuyển TB, BB phù hợp với diễn biến chiến đấu và thực tế của địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vận tải, thực hiện tốt nhiệm vụ vận chuyển TB, BB trong chiến đấu phối hợp.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Tổng Tham mưu, *Tác chiến phòng thủ tỉnh (thành phố) trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2010.
2. Bộ Tổng Tham mưu, *Bảo đảm hậu cần tác chiến phòng thủ tỉnh (thành phố) trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc*, Nxb QĐND, Hà Nội 2010.
3. Bộ Tổng Tham mưu, *Hoạt động chiến đấu phối hợp của lực lượng vũ trang địa phương với sư đoàn bộ binh tiến công địch cơ động*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2019.
4. Bộ Tổng Tham mưu, *Sư đoàn bộ binh tiến công địch cơ động*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2019 ■